
De la prévention des « conduites addictives » en milieu de travail à l'approche écosystémique des usages de produits

From the prevention of 'addictive behaviour' in the workplace to an ecosystemic approach to the use of psychoactive substances

Renaud Crespin

Sociologue et politiste, Chargé de recherche CNRS, Centre de sociologie des organisations, UMR 7116 CNRS/SciencesPo. Adresse : Sciences Po, 1 place Saint-Thomas d'Aquin, 75007, Paris.
renaud.crespin@sciencespo.fr.

Dominique Lhuillier

Professeure émérite de psychologie du travail CRTD-Cnam
dominique.lhuillier@lecnam.net

Gladys Lutz Nale

Ergonome, chercheure associée au CRTD/Cnam, directrice de l'association STUPP (Santé, travail, usages de psychotropes & prévention)
gladys.lutz@stupp.fr

Résumé : Dans le champ de la prévention des conduites addictives en milieu de travail, les orientations privilégiées par les politiques publiques rencontrent des résistances majeures en matière de mise en œuvre. Sur la base des résultats d'une recherche-action portant sur les appropriations locales d'un

projet national d'expérimentations de prévention, cet article interroge les obstacles cognitifs et organisationnels à une prévention écosystémique des usages de SPA. En suivant le travail de chargés de mission du réseau des agences régionales de l'Agence Nationale d'Amélioration des conditions de travail, il en caractérise également les conditions et les voies de dépassement des orientations prescrites. Celles-ci varient fortement selon les spécificités territoriales et les configurations d'acteurs. Resituer la prévention des addictions en milieu de travail dans l'analyse de l'organisation, des conditions de travail et de l'emploi emprunte ainsi différents processus allant de formes de déprise à l'affranchissement.

Abstract: In the field of preventing addictive behaviors in the workplace, the current policy guidelines meet major resistance during implementation. Based on the results of action research focusing on local appropriation of a national prevention experiment, this article examines the cognitive and organizational obstacles to ecosystemic prevention of psychoactive substance use. By following the work of project managers in the network of regional agencies of the Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, it also characterizes the conditions and ways in which the prescribed guidelines can be surpassed. These vary greatly depending on the specific features of each region and the configuration of actors involved. Setting the prevention of addictions in the workplace within the analysis of the organization, working conditions and employment thus involves various processes ranging from distancing to emancipation.

Mots-clés : politique de prévention, conduites addictives, milieu de travail, expérimentation, approche écosystémique, usages de substances psychoactives, organisation et conditions de travail, appropriation locale, configuration d'acteurs

Keywords: prevention policy, addictive behaviors, workplace, policy experimentation, ecosystem approach, psychoactive substances use, organization and working conditions, local appropriation, configuration of actors

Introduction

Dans le champ de la prévention des conduites addictives en milieu de travail, les orientations privilégiées par les politiques publiques et les institutions en charge de leur mise en œuvre, rencontrent des résistances majeures. Celles-ci tiennent notamment au vocabulaire et aux représentations associées. La prééminence des références aux *addictions* (Fortané, 2010) et *risques* (Borraz, 2008) pour la santé, la sécurité et la performance des organisations productives tend à invisibiliser la double face des substances psychoactives (SPA), à la fois « poisons et remèdes » (Morel, 2007, p. 33) et de leurs usages en milieu professionnel (Crespin *et al.*, 2015). Cette focalisation sur les addictions favorise la prévalence de la prévention tertiaire en milieu de travail et la psychologisation l'accompagnant (Lhuilier, 2021). Pour s'en déprendre, il faut sans doute revenir aux activités de travail et reconnaître les usages de SPA comme des ressources pour les travailleurs-usagers et les organisations de travail. Dans cette lignée, et prolongeant de précédentes investigations (Crespin *et al.*, 2017)¹, une recherche-action a été conduite avec l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail (Anact) dans plusieurs régions françaises. Cette recherche-action visait à explorer les contextes de travail et d'emploi et à caractériser les obstacles institutionnels et professionnels à une prévention écosystémique des usages des SPA, afin de réactualiser les analyses, les pratiques et les politiques de santé publique sur la « prévention des conduites addictives en milieu professionnel ». Cette perspective intègre donc la prise en compte des organisations et conditions de travail, des normes de travail et d'usage, des rapports sociaux de travail comme des spécificités socio-économiques des territoires.

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), en charge de la conception et animation de la politique publique en matière d'addictions, au niveau national et territorial, a lancé en 2021 un nouveau dispositif dit *Esper* (*Les entreprises et les services publics s'engagent résolument*). Pour

-
1. Une recherche précédente, centrée sur le sens de ces usages en milieu de travail, a mis en évidence quatre fonctions professionnelles des SPA : s'anesthésier, se stimuler, récupérer, s'intégrer. Si ces travaux montrent que ces consommations constituent des ressources pour l'activité et plus globalement la vie professionnelle, ils restent centrés sur les effets attendus par les usagers.

les pouvoirs publics, ce programme doit répondre à « la nécessité de briser les tabous et de mobiliser tous les acteurs du milieu professionnel ». Dans cette optique, ce dispositif public comprend une charte d'engagement et l'animation des réseaux locaux de ses signataires. Il inclut également la mise à disposition d'outils pour ce faire. L'Anact, à qui est confiée sa mise en œuvre, propose de renforcer la démarche d'engagement d'Esper en la complétant par un projet de recherche-action : Prev'camp (*Prévention des conduites addictives en milieu professionnel*). Deux objectifs sont assignés à ce dernier : analyser et expérimenter. Il s'agira donc d'identifier les leviers complétant les approches classiques de prévention des conduites addictives, essentiellement orientées vers l'identification et le « traitement » de personnes souffrant de troubles addictifs, par une approche organisationnelle. Cette recherche-action, en privilégiant la prévention primaire, entend intégrer aux analyses et perspectives d'actions les usages de substances psychoactives (SPA) des professionnels dans leurs (inter)relations avec le travail réel (au sens de l'ergonomie).

De plus, cette approche organisationnelle prévoit de développer les expérimentations dans les territoires grâce aux agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) et à l'enrôlement de différents partenaires locaux : entreprises publiques et privées, acteurs de la santé publique et de la santé au travail, de l'addictologie et de la réduction des risques.

Menée conjointement dans ces territoires, la mise en œuvre du dispositif Esper et de la recherche-action Prev'camp² débute en 2022. Malgré son ambition et ses premiers résultats prometteurs, la réduction des financements publics conduit l'Anact à devoir arrêter cette recherche-action en 2024. Et la même année, la poursuite d'Esper est confiée par la Mildeca à un opérateur privé, un cabinet de conseil, d'audit et d'expertise.

Cet article rend compte du déplacement – porté par les Aract et réalisé avec les parties prenantes – de la forme classique de la prévention des conduites addictives vers l'analyse et la transformation de l'organisation et des conditions de travail et de l'emploi. Il renseigne également les obstacles cognitifs, institutionnels et matériels

2. Ce projet complémentaire d'Esper de la Mildeca a fait l'objet d'un cofinancement du FLCA et de la Cnam dans le cadre d'une réponse à un appel à projets.

rencontrés dans la mise en œuvre de ce travail. Enfin, il révèle les conditions et voies de dépassement de ces obstacles.

Problématique et méthodologie

Au vu du caractère innovant de la recherche-action envisagée, l'Anact a sollicité trois chercheurs (un sociologue, une clinicienne du travail et une ergonome) pour accompagner les expérimentations locales prévues dans ce projet. Cette recherche-action s'est déroulée de décembre 2022 à juin 2024. L'ensemble des Aract a été impliqué et cinq d'entre elles ont contribué plus directement à cette recherche-action. Ici, nous retiendrons la présentation des travaux engagés par des chargés de mission de trois Aracts sur leur territoire respectif.

Classiquement, en science politique, la mise en œuvre d'un programme d'action publique s'étudie comme un processus de type « top-down », le centre décidant et fournissant les ressources. Au fait des limites des approches descendantes, réductrices et peu soucieuses des dynamiques et spécificités locales (Sabatier, 1986 ; Padioleau 1982 ; Lascoumes et Le Galès 2007), nous avons centré notre enquête sur les appropriations localement situées de ce programme s'inscrivant dans les orientations portées par la Mildeca, et sur les expérimentations associées à la recherche-action. Ce qui nous a conduits à analyser les logiques de distanciation, de réinvestissement, d'emprunt ou d'imprégnation, en fonction des ressources dont les acteurs disposent localement (Crespin, 2014). De fait, ces deux volets, application d'orientations définies par les politiques publiques nationales et construction de démarches territoriales à partir des caractéristiques organisationnelles ancrées dans leur contexte, impliquent des mouvements opposés : du top-down au bottom-up.

La méthodologie d'enquête est plurielle. Tout d'abord, elle inclut l'observation participante de cinq réunions avec l'Anact et les agences concernées sur le cadrage initial du projet de recherche-action. Ensuite, l'observation de l'activité des chargés de mission impliqués dans la conduite des deux types d'action (charte Esper et projet expérimental) au sein des Aract où les chercheurs ont travaillé. Leurs activités intégraient à la fois la conception et la mise en œuvre des actions de prévention avec les différents acteurs privés et publics territoriaux (entreprises, associations de prévention, fédérations de professionnels, organismes publics). Un séminaire avec l'ensemble

des chargés de mission des Aract et 13 réunions de recherche avec un groupe de chargés de mission volontaires ont permis une analyse collective sur les pratiques et le sens des actions menées. En outre, près de 50 entretiens individuels formels et informels, ont été menés tout au long du projet. Enfin, nous avons traité une abondante littérature grise provenant de nombreux organismes, publics et privés³, ayant produit des expertises et outils sur les addictions en milieu de travail. Cette littérature est notamment mobilisée par les Aract et leurs partenaires pour formaliser localement des actions de prévention.

Notre méthodologie repose donc principalement sur l'accompagnement des chargés de mission dans leur activité pour observer directement les « expérimentations en train de se faire ». Cette démarche favorise une relation avec eux comme « partenaires » du travail d'analyse de leur activité (Teiger, 2007). Elle aide à comprendre comment les interdépendances professionnelles dans lesquelles sont pris les acteurs locaux intervenant en santé/travail orientent les modes de coopération comme les types de prévention mises en œuvre.

La première partie de cet article éclaire les ressources mobilisées et les contraintes comme les difficultés rencontrées dans la réalisation des expérimentations que suppose la recherche-action. Ensuite, nous montrerons comment dans certaines configurations locales, les acteurs locaux ont pu, au moins en partie, se déprendre de ces contraintes pour expérimenter de nouvelles modalités d'action. Enfin, le cas de la Martinique est spécifiquement étudié. Il permet d'interroger les conditions sociales, historiques et professionnelles d'un affranchissement local vis-à-vis de politiques publiques initiées en France hexagonale.

I – Invisibiliser les usages, normaliser la prévention : la double emprise de l'addiction ou l'expérimentation empêchée

Ancien objet de controverses médicales, la notion d'addiction devient, dans les années 1990, la nouvelle façon de penser et de (se) représenter les consommations de substances psychotropes (Campbell, 2007).

3. Mildeca, Anact, Direction générale du travail, Institut national de recherche et de sécurité, Plan régional Santé travail, Addictions France, etc.

Évinçant ou rendant caducs les concepts de toxicomanie, d'alcoolisme et de tabagisme, elle s'ouvre aussi aux médicaments psychotropes et permet le traitement transversal des usages de produits, indépendamment de leur statut légal. Le succès de la notion d'addiction tient à sa dimension polysémique (Fortané, 2010). Elle permet notamment de définir un problème public (celui des addictions), de l'expliquer scientifiquement (par un mécanisme neurobiologique) et de formaliser un domaine d'intervention publique (la prévention ou la lutte contre les addictions), piloté par la Mildeca. Depuis les années 1990, cette polysémie favorise la circulation de cette notion, aujourd'hui omniprésente dans les espaces de production d'expertises (gouvernementale, judiciaire, sanitaire, privée...), comme dans différents espaces sociaux d'interprétation (académique, politique, journalistique, ordinaire...) des consommations de drogues licites et illicites.

À l'instar d'autres notions « attrape-tout » comme celles de résilience (Gilbert, 2013), l'addiction renvoie à une telle hétérogénéité de phénomènes qu'elle en devient floue (Bérard et Crespin, 2010). Dès qu'un comportement est répétitif, on le dit « addictif » : on parle ainsi d'addiction aux aliments, au travail, aux jeux vidéo ou d'argent, à la sexualité, au sport, aux réseaux sociaux, etc. L'espace de la prévention des risques professionnels n'échappe pas à l'emprise de cette catégorie. Sur nos terrains d'enquête, elle est couramment usitée par les acteurs de la prévention, que ceux-ci soient externes ou internes aux entreprises. Cet usage commun tient à sa diffusion par le biais d'un ensemble de documents d'expertise, d'avis et d'outils de prévention et de lutte contre les addictions au travail (Lemaître, 2015 ; Lutz, 2015 ; Crespin, 2015) dont ceux contenus dans le programme ESPER. Cette catégorie est ainsi au cœur de la grammaire de prévention mobilisée par les partenaires en addictologie de la Mildeca, les PRST (Plans régionaux de santé au travail) et les Aract. Elle est également centrale dans la mise en œuvre locale des actions et dispositifs de prévention des conduites addictives en milieu professionnel.

Par ailleurs, la circulation sociale de cette catégorie a de nombreux effets sur l'objet et le sens de la prévention.

Tempérance des échanges et invisibilisation des usages de SPA : la catégorie d'addiction au service d'une prévention classique en milieu professionnel

Lors de la plupart des actions de prévention menées avec les entreprises, les échanges portent essentiellement sur l'abus et les cas les plus « aigus ». Il s'agit de repérer les salariés dont les consommations, *a fortiori* si elles sont visibles, suscitent une inquiétude particulière – du point de vue de leur santé comme de leur travail et celui de leurs collègues. En parler en termes de « conduite addictive » et non en termes d'« alcoolique », « drogué » ou de produits consommés est moins clivant moralement et socialement. Cette notion tempère ainsi les interactions entre les différents acteurs sur un sujet « sensible », voire « tabou », dans les entreprises. Elle permet aussi de décliner dans les espaces de travail des mesures de prévention classiques en matière de lutte contre les addictions. À l'instar des programmes menés dans les établissements scolaires ou dans le secteur de la prévention routière, ces mesures sont essentiellement centrées sur la prévention secondaire (information-sensibilisation sur les risques pour responsabiliser les individus) et tertiaire (activation de mesures d'orientation et de prise en charge des « malades »). Les mesures de prévention primaire qui s'adressent souvent à une population « idéale » peu différenciée socialement présentent quant à elles le risque d'éloigner les populations les plus défavorisées ou précaires qui, tout en étant moins sensibles à la prévention, sont également celles dont les prévalences de consommations, par exemple de tabac, restent les plus élevées (Peretti-Watel, 2013). Cette prévention classique consiste également à rappeler les règles et les normes incombant à l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail : actualisation des outils de gestion des risques comme le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ou des outils de management comme le règlement intérieur. Dans cette logique normative, les consommations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction et de surveillance, par exemple par le dépistage (Crespin, 2018). La prévention vise alors à doter l'entreprise des moyens de juger de la conformité des salariés à ses règles internes, pour pouvoir, le cas échéant, engager des sanctions.

Notre enquête montre aussi que ce recours ordinaire à la notion d'addiction et aux actions associées invisibilise les usages de produits aux effets plus banalisés, comme les médicaments, le café ou

le tabac, et la question des interrelations entre consommations de produits et travail. L'explication de ces usages de produits au travail est alors renvoyée à des états spécifiques de salariés « vulnérables » ou « malades ». Cette vision fabrique une distinction entre « sains » et « malades » et traduit une attribution causale univoque : la vulnérabilité de certains serait la cause du trouble (Lhuillier, 2017). De plus, elle enferme les salariés dits « concernés » dans des identités individuelles réduites à ces consommations (Gabe, 1986 ; Campbell, 2008).

Aussi, la prévention courante des addictions au travail, fondée sur des dispositifs de gestion différentielle des salariés, n'interroge pas les raisons sociales, organisationnelles et professionnelles des consommations. Elle ne permet donc pas de saisir les fonctions de ces usages de produits ni de les explorer comme d'éventuels symptômes d'organisations de travail saturées de contraintes. Elle passe aussi sous silence les usages régulés de produits par les salariés pour tenir au travail et tenir le travail. La focalisation sur les « addictions » occulte ainsi les usages professionnels concrets de produits au travail et en dehors. Plus encore, la catégorie d'addiction offre des solutions descendantes et parcellaires à un problème pluridimensionnel.

Des coopérations locales sous dépendances : contraintes multiples et clôtures expertes

Les formes de coopération locales ont également conduit à prolonger l'invisibilisation des logiques socio-organisationnelles de ces consommations au travail.

En effet, en tant que catégorie d'action publique, le référentiel « addiction » facilite les collaborations entre les acteurs spécialisés et ceux intervenant dans d'autres domaines. Mais cette facilitation s'accompagne d'une clôture de l'expertise sur les schémas addictologiques. Ces collaborations sont encouragées par les agences publiques, nationales et locales, par le biais du financement de programmes intersectoriels de prévention. Ainsi, sur les terrains dans lesquels nous avons travaillé, nous avons pu observer le rôle central qu'occupe l'association Addictions France dans ces collaborations. Elle a été une partenaire récurrente des chargés de mission des Aracts et de leurs partenaires locaux. Cette récurrence a un impact direct sur le type de prévention proposée comme sur le partage des tâches et des compétences entre partenaires. Implantée sur tout le territoire,

cette association spécialisée participe à de nombreuses actions et projets de prévention en partenariat avec différentes organisations travaillant auprès de publics très divers (scolaire, festif, carcéral, professionnel...) identifiés comme « vulnérables » (jeunes, personnes précaires, en situation de handicap, sous-main de justice...). Or cette association ne dispose généralement pas des référentiels nécessaires à l'analyse du travail et aux dynamiques organisationnelles. Elle a pour mission « l'amélioration de la santé en agissant sur les addictions et leurs conséquences », et non l'amélioration du travail (organisation, conditions de travail, pratiques managériales) pour agir sur les facteurs favorisant le recours à la consommation de produits.

Ajoutons différentes contraintes ayant affecté les coopérations nécessaires à l'expérimentation du projet.

Tout d'abord, la coopération entre les partenaires mobilisés (services de santé au travail, entreprises, administrations, secteur associatif dans le champ de l'insertion professionnelle, agences régionales de représentation de l'État en matière de travail, d'emploi, de santé...) nécessite du temps et une certaine stabilité des acteurs locaux. Les expériences accumulées dans le cadre de projets successifs, sur différentes thématiques et enjeux du travail permettent la confiance et le partage de ressources et de savoir-faire rapidement remobilisables – pour répondre à des appels d'offres ou à des demandes de prestation émanant d'organisations publiques ou professionnelles. Cependant, une telle mutualisation des ressources est souvent fragilisée par le *turn-over* des acteurs de l'expertise en santé publique et en santé au travail. De plus, les transformations récentes du monde associatif, touché par une forte rationalisation de ses organisations, n'épargnent ni Addictions France ni les membres des 16 agences régionales de l'Anact (Hély et Simonet, 2016). Le temps de travail – notamment collectif, en coopérations internes et externes – des opérationnels est de plus en plus « compté » par leurs hiérarchies. Or la dimension expérimentale du projet Prev'camp exige un cadre temporel plus souple. L'expérimentation ne repose pas sur les routines existantes : il faut donc innover pour trouver les « bons » partenaires, construire de nouvelles modalités de travail et une offre de prévention originale qui soit susceptible d'intéresser les entreprises locales. Dans les agences régionales, comme à Addictions France, sauf rares exceptions, l'incertitude sur les objectifs et compétences mobilisables, sur les financements, les contraintes temporelles et organisationnelles

et la fragilité de certains partenariats locaux ont fortement impacté la possibilité de telles expérimentations. Dans nombre de régions, les collaborations ont davantage procédé d'une division du travail qui favorise la juxtaposition de compétences et la reconduction de la prévention classique. Cette reconduction s'opère notamment par l'utilisation de la documentation, des outils de communication, sensibilisation et formation (fiches et guides pratiques, vidéos et podcasts, diaporamas, affiches...) préexistants. Ceux-ci restent diffusés, de manière descendante, par les acteurs publics de la « prévention des conduites addictives » et les associations spécialisées en addictologie.

Une autre difficulté majeure dans la mise en œuvre de ce projet tient à la coopération avec les entreprises. Dans l'ensemble, celles-ci se sont montrées peu intéressées par le dispositif proposé (signer la charte Esper, participer au club ou à des sensibilisations et formations). Plusieurs facteurs expliquent ce désintérêt relatif. D'abord, la prévention des « conduites addictives » est perçue comme ayant essentiellement pour objet l'identification et le traitement des « personnes concernées » qui restent finalement peu nombreuses au regard d'autres enjeux jugés plus prioritaires (attractivité et recrutement, réglementation, risques psychosociaux, harcèlement...). Ensuite, les dispositifs s'avèrent lourds à mettre en œuvre en termes de temps et de membres du personnel à mobiliser tout en présentant le risque d'associer publiquement l'image des entreprises aux addictions⁴.

Néanmoins, des actions de prévention ont bien été menées. Ces actions, répondant le plus souvent à des demandes émises par des responsables de prévention, des membres des ressources humaines ou de la direction des entreprises. Ce sont d'ailleurs ces acteurs fonctionnels qui participent aux réunions, sensibilisations et formations dispensées, bien plus que les acteurs opérationnels, les encadrants ou les travailleurs. De fait, les appropriations locales du projet se sont souvent faites, dans des cadres où des experts de l'offre de prévention en addictologie rencontrent des experts de la prévention dans les entreprises. Ce qui a orienté les échanges vers les problèmes que posent les addictions aux différents prescripteurs de la prévention et du travail dans les entreprises. Les solutions se sont alors prioritairement tournées vers la mise en conformité des entreprises aux

4. L'image de l'entreprise se trouve plus valorisée à travers son engagement dans la lutte contre le cancer par exemple : toutes les pathologies ne se valent pas.

règles de natures juridique et organisationnelle, structurant leur responsabilité en matière de sécurité et de santé au travail. Du fait de l'absence des salariés dans l'analyse de la demande et de la définition des besoins, leurs savoirs, expériences et pratiques de consommation ne sont pas ou peu pris en compte. On voit ici la complexité de l'ouverture aux perspectives organisationnelles et de dialogue social.

Pour autant, la recherche-action a permis de repérer que, dans certains territoires et sous certaines conditions, ce cadre de coopération et d'expérimentation collective a pu se construire.

II - Se déprendre des addictions pour prévenir les usages de SPA : Prev'camp à l'épreuve de deux territoires

Dans les régions-Centre-Val de Loire (CVDL) et Occitanie, comme dans d'autres régions, la formation, l'expérience et le temps dont disposaient les chargés de mission des Aracts et leurs interlocuteurs ont progressivement, à l'épreuve du travail partagé, rendu possibles des déplacements vers la prévention primaire, la réduction des risques et la reconnaissance de l'expertise des professionnels-usagers. Ces déplacements ont ainsi permis de resituer la question des usages de produits dans des savoirs et savoir-faire préexistants en santé-travail, concernant les risques psychosociaux (RPS), la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT), les espaces de discussion sur le travail (EDT), les maladies chroniques et la prévention de la désinsertion professionnelle. Mobilisant depuis plusieurs années les acteurs de l'entreprise (ressources humaines, services de santé au travail, management, missions handicap...), ces grands chantiers sont plus directement rattachés à la question de l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail.

Ces multiples déplacements ont ainsi participé à dé-spécifier les « conduites addictives » et à les dégager du référentiel central de l'addiction et de l'addictologie. Toutefois, les conditions de ces déplacements varient fortement selon les territoires. À partir de nos observations, trois processus de dé-spécification, non exclusifs, peuvent être distingués et caractérisés. Ils se différencient en fonction des configurations d'acteurs intervenant localement en santé publique et santé-travail, de leurs compétences, de leurs ressources et des demandes des entreprises.

Une déprise par l'amont : entrer par le travail pour sortir du silo segmentant les actions en santé-travail

Pour l'Aract Centre-Val de Loire, une des actions menées a d'emblée consisté à se décaler du prisme des addictions pour se centrer sur celui du travail. Plusieurs facteurs ont conduit à cette première forme de déprise. Tout d'abord, cette déprise est suspendue à la demande même de l'entreprise. Ce facteur est essentiel car l'intervention dans les organisations est toujours favorisée par l'expression de besoins, d'attentes relatives à un problème ou une visée identifiée. Cette demande intervient après un diagnostic des risques psychosociaux (RPS), faisant état de problèmes structureaux liés à l'organisation du travail. Et la direction, nouvellement arrivée, souhaite engager une réflexion globale pour répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs. Dans ce cadre, l'entreprise a signé la charte Esper, a mis en place une cellule de médiation et a demandé aux chargés de mission de l'agence régionale de l'Anact d'y participer. Le deuxième facteur tient à la spécificité de cet établissement public national à caractère industriel et commercial. De grande taille, il est organisé en différentes directions gérant une large diversité de métiers et de statuts. Ces caractéristiques ont favorisé le choix d'une approche transversale non centrée sur les addictions. Le troisième facteur relève du partenariat avec l'Aract locale et de la cellule de médiation elle-même. Celle-ci est, dès le départ, conçue comme un outil devant permettre la prise de parole de tous les travailleurs en vue de transformer le travail et son organisation. La prévention des usages de produits devient alors un des objectifs envisagés des transformations proposées par la cellule. À l'issue de l'accompagnement de cet établissement, un dispositif d'écoute, permanent, est mis en place. Il dispose de compétences élargies sur plusieurs enjeux de prévention (RPS, harcèlement, discrimination). Ainsi, la prévention des addictions n'est plus installée à côté des autres « chantiers ». Elle relève d'une démarche plus globale, sortant ainsi d'une gestion en silo.

Faire avec les cadres institués pour s'en déprendre

En Occitanie, le diagnostic du Plan régional de santé au travail (PRST4, 2021-2025) documente la nécessité d'agir en amont des troubles musculosquelettiques et des troubles psychosociaux. Pour ce faire, il affirme que les actions qui visent à améliorer la santé au travail doivent se réaliser dans une perspective transversale, systémique,

coordonnées sur le long cours, construites du côté du dialogue social et de l'amélioration de l'organisation, des compétences. Il préconise des manières décroisées de travailler afin de produire de nouvelles connaissances par le croisement des données et des expériences.

Appuyées sur ce diagnostic et sur leurs compétences de psychologue du travail et d'ergonome, deux chargées de mission de cette Aract pilotent la mise en œuvre du dispositif Esper, tel que prescrit nationalement (12 entreprises signent la Charte d'engagement) et participent aux groupes de travail installés par le Plan régional de santé – groupes QVCT et Addictions). Cette dynamique organisationnelle est transversale. Déjà engagée sur le thème des addictions, cette agence régionale a construit sa légitimité avec les acteurs en place, un écosystème trans-institutionnel⁵ rodé autour de la mise en œuvre du Plan Régional de santé au Travail depuis plus de 15 ans. Engagées dans le projet de recherche-action, au temps de travail collectif qu'il organise, les chargées de mission s'affranchissent progressivement des méthodes et outils classiquement prescrits (supports d'Addictions France, boîte à outils Addict'aide⁶) tout en respectant le tempo des acteurs en présence : les autres partenaires et les entreprises signataires de la Charte Esper. Les chargées de mission agissent dans cet écosystème d'acteurs comme des porteurs d'innovation sociale, des « tiers de confiance » ou « institution frontière » (Berthou, 2018), privilégiant l'objectif de création de communs.

Concrètement, le travail des chargées de mission a déplacé l'intervention des entrées classiques « risque » ou « profil des salariés » (décriées par le Plan Régional de Santé Travail) vers la perspective organisationnelle et les outils éprouvés de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail (tels que les espaces de discussion sur le travail ; les outils de la QVCT ; les actions relatives à la prévention de la désinsertion des salariés vivant avec des maladies chroniques). Ce qui a permis l'analyse des fonctions des consommations de psychotropes, intégrée dans les perspectives choisies par les

-
5. Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), Agence Régionale de Santé (ARS), Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat), Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST), Addictions France et Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (Aract).
 6. Portail de ressources soutenu par le Fonds de lutte contre les addictions et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca).

entreprises elles-mêmes, de leurs priorités. Pour aider à comprendre et réduire en entreprise les risques liés aux usages de produits, ces chargées de mission se sont positionnées en analystes du travail. Leur objectif explicité aux interlocuteurs était clair : apprendre ensemble à prévenir *les conduites addictives* du côté, non plus des produits ou des cas individuels d'addictions, mais de l'organisation du travail. À partir de travaux en sous-groupes (avec comme consignes de décrire/discuter des situations réelles de consommations de psychotropes en lien avec le travail et les modes de régulation ; de décrire et discuter les actions de prévention des risques dans leurs entreprises, des objectifs poursuivis, des effets observés), un changement de nature des questionnements s'est opéré. Progressivement, les acteurs impliqués se sont approprié ces perspectives et y ont trouvé de nouvelles orientations pour agir. De retour à leur poste, le travail de chacun entre ces temps de réunions permettait de tester ces idées. Dans ce travail itératif, l'expérimentation a développé dans le territoire de nouvelles compétences partagées. L'écosystème d'action crée par la conjugaison des visées d'amélioration de la transversalité et les coopérations en santé, d'actions en prévention primaire, d'ancrage de la prévention des conduites addictives dans l'organisation du travail, favorisent la synergie.

Une déprise par itération : l'approche organisationnelle comme processus

Pour l'association Addictions France du Centre-Val de Loire, la recherche-action portée par l'Aract se présentait comme une opportunité : diversifier son offre de formation sur la prévention des addictions dans les entreprises en la nourrissant de l'approche organisationnelle préconisée par l'agence régionale. Ce partenariat lui garantissait une plus grande légitimité et crédibilité dans le domaine de la prévention en milieu de travail, lequel n'est pas au cœur de son expertise. Ce partenariat a permis la conduite de formations dans trois structures locales de réinsertion, dépassant l'approche classique de la prévention des addictions au travail au profit de l'approche organisationnelle.

Au départ, conformément à l'intitulé du projet Prev'camp, ces formations visaient à doter les entreprises de dispositifs pour « prévenir les conduites addictives en milieu de travail ». Aussi, les deux premières sessions ont été consacrées aux addictions et aux risques

sanitaires associés ; aux obligations légales et réglementaires des entreprises et aux outils dont ils disposent pour y répondre. Dans un premier temps, la division du travail entre Addictions France et les chargés de mission s'est donc faite par juxtaposition des compétences. Les usages professionnels de SPA ne sont alors pas directement abordés. Dans un second temps, la question du travail est réintroduite pour interroger cette approche classique. À l'aide de nouveaux outils et supports pédagogiques, les allants de soi et les représentations communes des consommations sont remises en question. Cette démarche réflexive permet alors de resituer l'analyse dans le cadre de situations concrètes de travail. Les usages ne sont plus seulement considérés comme importés dans l'entreprise mais comme d'éventuels symptômes de tensions issues de l'organisation et des conditions du travail. Il est alors possible, dans un troisième temps, d'élaborer avec les entreprises de réinsertion des solutions collectives, ajustées à leurs spécificités. La mise en place d'espaces de discussion sur le travail en fournit un exemple. Leur apport est double : ils favorisent l'expression de tous (encadrants et opérationnels) sur des pratiques réelles de consommations (individuelles ou collectives), souvent perçues comme tabous ou relevant de l'intime. Et ces espaces permettent de circonscrire les échanges aux liens qu'entretiennent les consommations de SPA avec le travail réel. Sans contester l'existence de consommations individuelles, il s'agit de rappeler qu'au travail, elles peuvent révéler des difficultés d'articulation entre vie privée et vie professionnelle, des cultures socioprofessionnelles ou des conditions de travail favorisant leur développement.

Ce qui est visé alors n'est pas les addictions, mais la détermination des moyens que les entreprises se donnent pour faire de leurs espaces de travail des lieux de réduction des risques.

III - Affranchissement des cadres prescrits : « la prévention des conduites addictives » à l'épreuve des Outre-mer

Le projet, tel que réalisé en Martinique, a opéré une inversion de la démarche : partir des réalités territoriales pour la construction partenariale d'une démarche de réduction des risques en milieu professionnel. L'expérimentation s'inscrit dans son contexte.

La Martinique se caractérise par son insularité, un vieillissement de la population (départ massif de la jeunesse pour suivre des études et/ou chercher un emploi en France Hexagonale ou à l'étranger), un contexte de chômage structurel⁷, la prévalence de familles monoparentales (des femmes et leurs enfants), un marché du travail composé essentiellement de petites entreprises familiales, d'entreprises de taille moyenne appartenant le plus souvent aux békés⁸, d'emplois publics nombreux, et de relations en emploi marquées par une conjugaison de paternalisme et de clientélisme et par la rudesse des rapports sociaux.

La « pénalité outre-mer »⁹ (France Stratégie, 2024) est patente : coût de la vie particulièrement élevé, l'essentiel des produits consommés étant importés, offre limitée de formations, difficultés d'accès à l'emploi des jeunes non-diplômés, importance du secteur de l'insertion. L'impact de l'héritage colonial sur la formation, l'emploi, le travail est majeur. Ainsi, on note une affirmation toujours répétée lors des entretiens réalisés : « *Ici, le passé n'est pas passé* ». Aussi, un retour sur l'histoire du travail (système esclavagiste et colonial) s'impose. Il permet de repérer les caractéristiques du rapport au travail salarié et la construction sociale de la distinction entre travail pour autrui (le maître, le béké) et travail pour soi, exercé à côté ou en marronnage (Oudin-Bastide, 2005, 2008). Ces fondements historiques et la rémanence de formes de domination héritées de la période coloniale, croisant inégalités de classe et inégalités ethno-raciales, éclairent l'ambivalence du rapport au travail et la prévalence de la pluriactivité. Le travail salarié est essentiellement perçu comme un travail contraint, celui réalisé « pour le béké ». Le « travail à côté » (Weber, 2009) est fréquent : travail informel, échanges de services, « coup de main ».

7. Les taux de chômage en Outre-Mer sont parmi les plus élevés de l'UE : 12,4 % en Martinique, 7,1 % dans l'Hexagone en 2023) ; 30 % des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté (14,5 % dans l'Hexagone),

8. Les Békés sont des descendants des premiers colons européens installés sur l'île comme propriétaires d'esclaves.

9. « Les personnes nées dans les Antilles ou à La Réunion ont en moyenne des perspectives beaucoup plus faibles de réussite éducative et professionnelle que celles nées en métropole – À origine sociale comparable, les natifs de ces territoires ont 20 % à 25 % de chances en moins d'obtenir un diplôme du supérieur, environ 12 % de chances en moins d'accéder à l'emploi, et 35 % à 45 % en moins d'occuper un poste de cadre » (France Stratégie, 2024).

C'est bien dans ce contexte marqué par les traces du colonialisme, la déception à l'égard de la départementalisation, le ressentiment à l'égard de l'État et les politiques publiques déclinées en Outre-Mer, que peut se comprendre la résistance à l'application de « ce qui vient de Paris », et l'attention portée aux caractéristiques territoriales. Parmi ces caractéristiques, qu'en est-il de la consommation des produits ?

Usages de substances psychoactives et impacts sanitaires en Martinique

Les données disponibles (Obradovic, 2020) montrent une très faible consommation de tabac et une consommation d'alcool plus intensive, des boissons plus fortement alcoolisées (rhum), plus concentrées dans certaines populations (en particulier les jeunes) et souvent sources de dommages socio-sanitaires¹⁰. Le cannabis, à la consommation banalisée, est disponible car produit localement. Globalement, l'hypothèse retenue dans ce rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) concernant la prévalence des « conduites addictives » est celle « des conditions de vie, moins favorables qu'en métropole, en particulier sur les plans socio-économique et sanitaire ».

Ici, on doit souligner que ces données ne font étonnamment pas état d'une autre problématique importante, aux effets sanitaires très marqués : les conduites alimentaires et la forte consommation de sucre, produit addictif consommé au travail et hors travail, non répertorié comme substance psychoactive par la Mission Interministérielle en charge de la conception de la politique publique de lutte contre les addictions. Le sucre est là, comme dans d'autres territoires d'Outre-Mer, à la fois un héritage de la production historique de la canne à sucre et un adjuvant des produits importés ou fabriqués dans ces ex-colonies (+35 % de sucre) (IRD, 2020). Ce produit a des effets majeurs sur la santé : la prévalence de l'obésité de 25 % en Martinique (15 % dans l'Hexagone), celle du diabète de 10 % (moyenne nationale de 5 %), en témoignent. Le diabète peut conduire à des inaptitudes, l'obésité constitue un handicap pour nombre de postes de travail. Ajoutons les effets invisibles du sucre sur le cerveau, les facultés mentales et la productivité au travail : fluctuation de l'énergie, de la concentration, troubles de l'humeur, altération de la mémorisation et capacité à réaliser des tâches complexes.

10. 39,1 % des accidents mortels en Martinique (30,2 % dans l'Hexagone).

Au vu de ces caractéristiques territoriales, d'autres hypothèses relatives au sens des usages des SPA peuvent être envisagées : les consommations de produits, pendant, après la journée de travail salarié, mais surtout le week-end, contribuent à se soustraire au poids des contraintes : le travail « pour le patron », le défaut de reconnaissance, de possibilité de changer d'emploi et dans de nombreux secteurs, la pénibilité du travail. Les consommations de produits installent un temps « à côté » du temps imposé par l'organisation du travail et l'employeur : celui de la liberté, de la subversion et de la reconstruction d'autres formes de liens à l'autre. Ces consommations sont des signes et vecteurs d'une soustraction à la contrainte, à l'enfermement, aux interdits. Elles trouvent leur acmé durant le temps du carnaval et sa fonction cathartique (Agier, 2017).

Elles constituent des réponses-ressources aux contraintes de l'activité et des rapports sociaux marqués par une hiérarchie sociale arrimée aux nuances de la couleur de la peau, et/ou à des conditions de vie sans perspectives d'amélioration. C'est notamment le cas pour les jeunes non-diplômés condamnés au précarité¹¹. On sait plus globalement que le chômage ou le travail intermittent favorisent la consommation de produits (Amado et Lhuillier, 2023).

La prévention des usages de SPA en Martinique repose sur les mêmes principes qu'en France hexagonale, au motif que la Martinique est un département français et que les politiques publiques doivent s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République. Ce qui conduit à invisibiliser les connaissances locales relatives aux produits consommés, au sens de ces consommations, et à méconnaître les savoirs des expertises locales et des usagers.

Construire la prévention des risques associés à certains usages de produits

Au vu de ces caractéristiques territoriales, à la fois bien connues par les acteurs locaux et éclairées par la coopération interinstitutionnelle

11. Le précarité : « un infra-salariat qui se développe en deçà de la société salariale et qui ne permet plus d'assurer l'indépendance économique et sociale des travailleurs ». Castel, Robert (2007), « Au-delà du salariat ou en deçà de l'emploi ? L'institutionnalisation du précarité », in Serge Paugam (dir.), Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales, Paris, Presses universitaires de France, pp. 415-433.

et interprofessionnelle, les effets de la consommation de sucre sur la santé au travail et sur l'état de santé de la population (mis en lumière par un médecin du travail impliqué dans la démarche) ont pu être intégrés dans la recherche-action et l'expérimentation associée. L'animation des dispositifs installés par le chargé de mission, psychologue du travail de formation, engagé dans cette recherche-action a cherché à favoriser l'expression d'une reconnaissance des réalités territoriales, le plus souvent mises sous silence au profit de présentations en conformité avec « le national ». L'expression devient plus libre, même si des traces d'ambivalence sont perceptibles : peut-on dire ce qui est habituellement tenu en coulisse ? On observe parfois un important décalage entre ce qui est dit en entretien individuel et en réunion publique. Mais avec le temps et la construction de la confiance dans la coopération, l'expression sur les situations et le travail réel prévaut. La valorisation du territoire s'entend au prisme de ses différentes dimensions : géographique, historique, économique, symbolique et culturelle. L'attachement des acteurs à un espace physique donné, au sein duquel ils identifient des valeurs plus ou moins partagées et défendent des ressources matérielles mais aussi immatérielles (culture, langue...) est manifeste. Ce sont des dimensions qui contribuent à la fonction identitaire du territoire et à ses transformations (Pesqueux, 2014).

La construction d'un maillage d'acteurs institutionnels territoriaux et de réseau de partenaires (employeurs, réseaux relais et organisations syndicales) pour définir des stratégies et actions de réduction des risques et les dommages des consommations s'appuie aussi sur l'histoire des coopérations antécédentes de cette agence régionale et de ses chargés de mission sur d'autres thématiques, et sur celles de chacun lors de relations personnelles et professionnelles sur ce territoire qui favorise les interconnaissances. Ce maillage a pour objectif de proposer une recherche interventionnelle assise sur une approche collective de la prévention. Aussi, le cadre de la démarche a été progressivement co-construit dans les échanges au sein du comité d'animation territoriale qui réunit l'ensemble des partenaires¹² (réunions trimestrielles), et ses membres ont participé activement aux

12. La Direction des Risques Professionnels de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, l'Observatoire Régional de la Santé, la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), des Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST), un Caspa de la Croix-Rouge et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (Aract).

actions engagées collectivement, tant dans les ateliers proposés que lors d'une table ronde publique¹³ visant à promouvoir la démarche sur l'ensemble du département.

Ce travail est bien un travail de territorialisation (Le Bail *et al.*, 2021), de coopération entre acteurs-partenaires, de reformulation des enjeux et de construction de ressources cognitives, matérielles.

On observe tout au long du processus les effets des coopérations développées : la transformation des représentations, le déplacement de perspective de la prévention tertiaire ciblant des personnes fragilisées par l'addiction ou réduite au rappel du cadre réglementaire et sanctions associées aux transgressions, vers une approche organisationnelle, la réévaluation et priorisation des types de produits consommés localement.

L'approche systémique retenue ouvre le champ de la réflexion et l'exploration de perspectives d'actions.

Ainsi, l'approche défendue par cette agence régionale et le chargé de mission animateur du projet s'appuie sur l'analyse des liens potentiels entre les transformations du travail, les contraintes du travail et la santé au travail à travers trois dimensions imbriquées des relatives aux consommations en milieu professionnel : des conditions de travail dégradées participent à l'émergence ou au renforcement de consommations de produits; les usages de produits hors travail peuvent conduire à surexposer aux risques professionnels les salariés engagés dans ces consommations, leurs collègues, voire leurs « clients » ; des cultures socioprofessionnelles et/ou des environnements de travail facilitent le développement ou le renforcement de ces consommations.

On voit ici qu'il est indispensable de considérer l'organisation du travail comme faisant partie d'un système plus global. Les caractéristiques territoriales éclairent le sens donné au travail : « poids de l'histoire », étroitesse du marché du travail insulaire, inadéquation entre les besoins et les qualifications de la population active, produits disponibles et consommés...

Aussi, le décroisement de la thématique usages de produits a été favorisé par son inscription dans celle des risques psychosociaux, fil conducteur des différentes thématiques traitées par l'équipe

13. Voir YouTube : <https://youtu.be/FNwV28wH95A?si=hj9fgys4Z8dePSrC>.

de cette agence régionale. En effet, l'analyse des besoins est une clé d'entrée dans les organisations. Le travail d'analyse des demandes permet d'aller au-delà de la focalisation sur « les cas individuels problématiques », qui suscitent peu d'investissement tant d'autres priorités sont identifiées, à la question plus globale des transformations du travail et de l'émergence de problématiques suscitant des demandes fréquentes des entreprises ou des incitations par les politiques publiques (obligations réglementaires, incitations à la négociation collective, axes des Plans régionaux en santé au travail...). En prévention des risques psychosociaux, « les conduites addictives » sont identifiées comme un trouble psychosocial et l'usage de produits comme symptôme de conditions de travail dégradées. D'autres axes de travail ont favorisé aussi une réflexion sur leur lien avec le recours aux produits dans le travail : harcèlement sexuel et violences sexistes et sexuelles, qualité du dialogue social et du dialogue professionnel... Il s'agit bien d'entrer en priorité par les enjeux qui pré-occupent le plus, et au quotidien, les entreprises et administrations, afin d'y d'insérer progressivement la problématique de la réduction des risques associés aux consommations.

De plus, le déplacement des « conduites addictives » à la réduction des risques et des dommages permet de reconnaître la place des consommations dans les vies de chacun et dans celle du territoire, de déstigmatiser ces usages et d'ouvrir le champ de l'action aux compatibilités/incompatibilités entre usages et activités. On peut ne pas souffrir d'addiction, fêter le départ en retraite d'un collègue et prendre son poste de travail (conduire un bus, monter sur un échafaudage...), dans un état préjudiciable à la sécurité. La perspective de la réduction des risques permet de sortir du tabou et de parler des activités de travail. La proposition d'espaces de discussion implique la reconnaissance de la capacité des usagers à s'exprimer sur leurs consommations, à échanger sur les fonctions de celles-ci, sur les modes de régulations individuelles et collectives de ces conduites, à différencier la part ressources/risques de ces usages.

Dans ces perspectives, des « causeries » sont proposées dans les milieux de travail en optant pour le choix du terme consommations (et non plus « addiction ») et en privilégiant la pratique de la langue créole.

L'expérimentation de la recherche-action en Martinique ouvre des perspectives qui vont au-delà de ce territoire. Elle éclaire plus

globalement la mise en œuvre des politiques publiques nationales dans les outre-mer, mais aussi au-delà. La démarche partant du réel du travail et des territoires révèle des champs d'action sous-estimés ou invisibilisés. Ainsi s'impose la reconnaissance du sucre comme produit addictif aux effets délétères pour la santé, la double inscription de cette question en santé au travail et en santé publique, l'inadéquation des mesures de « prévention des conduites addictives » (remplacement de l'alcool lors des pots ou à la cantine par des boissons sucrées). On note également l'importance de la pluriactivité (cumul d'emplois ou emploi et travail informel) dans les outre-mer, là où le salariat est marginal dans l'histoire longue de ces territoires. Le développement de la pluriactivité concerne aussi de plus en plus la France hexagonale (Bureau *et al.*, 2019). Aussi, il mériterait d'être intégré à l'analyse globale des problématiques de santé-travail.

Conclusion

La prévention en matière de santé au travail et de santé publique gagnerait à être décolonisée (Ridde *et al.*, 2023). Il s'agit de concevoir la recherche interventionnelle au plus près des situations réelles et avec les acteurs inscrits dans l'écosystème et son histoire, afin de veiller à l'adaptation pratique de l'action publique (Guyon, 2016). Plus généralement, cette recherche-action et les expérimentations territoriales observées montrent tout l'intérêt de renverser la logique de construction des programmes de prévention. La pertinence de ces programmes repose d'une part sur la mise en place d'une véritable relation partenariale entre les différents acteurs. D'autre part, elle requiert la prise en compte, à partir des conditions de travail, du vécu des salariés, et non pas seulement de leurs problèmes individuels d'addictions.

La comparaison des modalités de conduite et d'appropriation du double projet – Esper, sa charte d'engagement et ses ressources classiques associées et la recherche-action Prev'camp, privilégiant l'approche écosystémique des usages et de la réduction des risques – montre les tensions entre ces deux démarches.

On repère aussi une forte variabilité, selon les territoires et configurations locales d'acteurs. Les contrastes observés tiennent à de nombreux facteurs : taille des équipes dans ces agences régionales et ressources dédiées, ancienneté dans le métier de chargé de mission

intervenant en milieu de travail, expérience de projets sur des thèmes en lien avec le thème, connaissances du contexte local régional et ressources partenariales. Le degré de dépendance au cadre prescrit descendant (tel qu'Esper) est hétérogène. Il varie en fonction des expériences antérieures, légitimant la construction d'une démarche ancrée localement et innovante par son approche, fondée sur l'activité et l'organisation du travail.

La construction territoriale implique d'identifier et d'analyser les demandes-problèmes et de faire l'inventaire des ressources déjà existantes dans chaque configuration partenariale locale.

L'inscription de cette démarche dans des interventions précédentes ou en cours sur d'autres thèmes (risques psychosociaux, égalité professionnelle, maladies chroniques, espace de discussion sur le travail...) constitue un levier important pour mobiliser les acteurs de l'entreprise. *A contrario*, la segmentation des thématiques et champs d'action dans le domaine de la prévention conduit à la dispersion et à l'accroissement du travail des chargés de mission et de leurs partenaires.

Enfin, la construction du territoire comme cadre d'action dépend aussi des coopérations multi-acteurs antécédentes et des modalités d'animation des espaces de travail communs. L'analyse comparée, menée ici ou ailleurs, montre que « la configuration partenariale territoriale » constitue « un espace indispensable pour travailler les objectifs, les ressources et les besoins perçus des destinataires d'une politique publique et des acteurs d'un territoire à définir » (Jolivet et Zara-Meylan, 2023). La coopération et sa pérennisation se construisent dans l'action. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'identifier les « bons » (critères variables) acteurs du territoire, mais de mettre en œuvre des modalités de travail et des interrelations qui font de ces acteurs d'authentiques partenaires et pas seulement des représentants institutionnels ou organisationnels. Pour ce faire, l'attention portée aux activités concrètes des partenaires, la valorisation de leur complémentarité, la définition collective des besoins, des objectifs et des actions prioritaires, favorisent l'engagement des acteurs territoriaux sollicités. Au-delà des types de dispositifs mis en place (comité de pilotage, groupe projet, ateliers d'information-sensibilisation...), les modes d'animation choisis peuvent favoriser des apprentissages entre partenaires, par le partage et la transmission d'expériences, la réflexivité collective sur les actions coréalisées. Ainsi, le décroisement

institutionnel et l'ouverture à la pluriprofessionnalité constituent des ressources collectives pour l'action en santé dans des mondes du travail nécessairement ancrés dans des territoires.

Références bibliographiques

- Agier, M. (2017). Le rite carnavalesque. Toujours recommencé, entre transgression et sédition. *L'Observatoire*, 50(2), 67-69.
- Amado, G. et Lhuilier, D. (2023). Place des conduites addictives dans les histoires de travail et de chômage. *Psychotropes*, 29(4), 125-149. <https://doi.org/10.3917/psyt.294.0125>
- Bérard, Y. et Crespin, R. (2010). *Aux frontières de l'expertise : dialogues entre savoirs et pouvoirs*. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- Berthou, V. (2018). *De l'intention d'innovation à son institutionnalisation. Le cas des Living Labs en Santé & Autonomie*. Thèse de doctorat en sociologie, Université de Technologie de Troyes.
- Borraz, O. (2008). *Les politiques du risque*. Paris : Presses de Sciences Po.
- Bureau, Ch., Corsani, A., Giraud O. et Rey F. (2019). *Les zones grises des relations de travail et d'emploi*. Buenos Aires : Teseo.
- Campbell, N. (2007). *Discovering addiction: The science and politics of substance abuse research*, Ann Harbor: University of Michigan Press.
- Campbell, N., & Shaw, S. (2008). Incitements to discourse: Illicit drugs, harm reduction, and the production of ethnographic subjects. *Cultural Anthropology*, 23(4), 688-717.
- Crespin, R. (2014). Des objets techniques aux objets-frontières : appropriation et dissémination des instruments d'action publique. *Sciences sociales et santé*, 32(2), 57-66.
- Crespin, R. (2015). Le sens des mesures. Usages et circulation des chiffres dans la définition du problème public des drogues au travail. *Psychotropes*, 21(1), 35-54.
- Crespin, R., Lhuilier, D. et Lutz, G. (2015). Les fonctions ambivalentes de l'alcool en milieu de travail : bon objet et mauvais objet. *Les Cahiers internationaux de psychologie sociale*, 107(3), 375-401. <https://doi.org/10.3917/cips.107.0375>
- Crespin, R. (2017). Prévenir les dangers des usages de drogues au travail : la régulation comparée de la carrière transnationale des tests de dépistage biologique – États-Unis et France. In Ph. Auvergnon (dir.). *Drogues illicites et activité salarié : éclairages de droit étrangers et pluridisciplinaires* (pp. 281-306). Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux.
- Crespin, R., Lhuilier, D. et Lutz, G. (dir.) (2012). *Se doper pour travailler*. Toulouse : Érès.
- Fortané, N. (2010). La carrière des « addictions ». D'un concept médical à une catégorie d'action publique. *Genèses*, 78(1), 5-24.
- France Stratégie (2024). *Naître en Outre-Mer : de moindres opportunités que dans les autres régions de France*. Note d'analyse, 137.

- Gabe, J., & Thorogood, N. (1986). Prescribed drug use and the management of everyday life: the experiences of black and white working-class women. *The Sociological Review*, 34(4), 737-772.
- Gilbert, C. (2013). De l'affrontement des risques à la résilience. Une approche politique de la prévention. *Communication & langages*, 176(2), 65-78.
- Guyon, S. (2016). Trajectoires post-coloniales de l'assimilation. *Politix*, 116, 9-28.
- Hély, M. et Simonet, M. (dir.) (2016). *Le travail associatif*. Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest.
- Jolivet, A. et Zara-Meylan, V. (2023). Expérimentations en faveur du maintien en emploi des seniors : une analyse des configurations partenariales territoriales à partir de l'activité des chargés de mission de cinq ARACT. *Activités* [en ligne], 20(2).
- Lascoumes, P. et Le Galès, P. (2018). *Sociologie de l'action publique* (2^e éd.). Paris : Armand Colin.
- Le Bail, Cl., Cerf M. et Yannou-Le Bris, G. (2021). La relocalisation des systèmes alimentaires dans les territoires : quel cadre d'analyse en ergonomie ? *Activités* [en ligne], 18(2).
- Lemaître, F. (2015). L'appropriation du paradigme addictologique à la SNCF : entre réceptions négociées et usages détournés. *Psychotropes*, 21(1), 55-76.
- Lhuillier, D. (2017). Quelle reconnaissance des vulnérabilités au travail ? *Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé* [en ligne], 19(1). <http://journals.openedition.org/pistes/4942> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/pistes.4942>
- Lhuillier, D. (2021). L'individualisation du travail au cœur de la psychologisation. In S. Le Garrec (dir.). *Les servitudes du bien-être au travail. Impacts sur la santé* (pp. 53-68). Toulouse : Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.legar.2021.01.0053>
- Lutz, G. (2015). Pratiques addictives en milieu de travail : impasses du concept et nouvelles perspectives. *Psychotropes*, 21(1), 13-34.
- Lutz, G. (2020). Usage et mésusage de la rhétorique des addictions en santé au travail. *Sciences de la société* [en ligne], 106.
- Méjean, C. (dir.) (2020). *Alimentation et nutrition dans les départements et régions d'Outre-Mer*. Marseille : IRD, coll. « Expertise collective ».
- Obradovic, I. (2020). *Drogues et addictions dans les outre-mer. État des lieux et problématiques*. Paris : OFDT, coll. « Théma ».
- Oudin-Bastide, C. (2005). Travail et émancipation. In C. Oudin-Bastide (dir.). *Travail, capitalisme et société esclavagiste : Guadeloupe, Martinique (XVII^e-XIX^e siècle)* (pp. 305-336). Paris : La Découverte.
- Oudin-Bastide, C. (2008). La relation au travail dans la société esclavagiste de la Guadeloupe et de la Martinique (XVII^e-XIX^e siècles) », *Travailler*, 20, 137-154.
- Padioleau, J.-G. (1982). *L'État au concret*. Paris : Presses universitaires de France, coll. « Sociologie ».
- Peretti-Watel, P. (2013). La prévention primaire contribue-t-elle à accroître les inégalités sociales de santé ? *Revue d'épidémiologie et de santé publique*, 61(S3), 158-162.

- Ridde, V., Fillol, A., Kirakoya-Samadoulougou, F. et Hane, F. (2023). Agir pour une décolonisation de la santé mondiale en France... et ailleurs », *Santé publique*, 35(2), 109-113.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.
- Teiger, C. (2007). De l'irruption de l'intervention dans la recherche en ergonomie. *Éducation permanente*, 170, 35-49.
- Weber, Fl. (2009). *Le Travail à côté. Étude d'ethnographie ouvrière*. Paris : eMeSS/INRA.